

ため、自分が診療する施設にどのような専門家がいるのかをあらかじめ把握していることが重要である。また、緊急時でもすぐにコンサルテーションできるように、日頃から専門領域の診療科と良好なコミュニケーション保持しておくことが大切である。

a 放射線療法

痛みを有する骨転移や腫瘍圧排による神経障害性疼痛、腫瘍浸潤に伴う痛みなど、腫瘍の縮小によって痛みを緩和することが可能と判断される場合に考慮される。痛みを有する骨転移に対しての有効率は60%以上あると報告されており、分割照射（たとえば計30 Gyを10回に分割して照射）する場合と単回照射（1回8 Gy照射）である場合とで除痛率に差がないが、単回照射の場合は再照射率が高いことが報告されている⁸⁾。

b 神経ブロック

局所麻酔薬やアルコールなどの神経破壊薬を用いて痛みの原因となる神経の伝達を遮断する方法である。腹腔神経叢ブロックなどの神経叢ブロック、硬膜外腔やくも膜下腔にカテーテルを留置して行う脊髄内鎮痛などがある。

c インターベンショナル・ラジオロジー (IVR)

経皮的椎体形成術が代表的である。椎体転移などで神経根や脊柱管内に腫瘍が浸潤していない場合の体動痛の制御を目的に行うことが多い。転移により脆弱化した椎体にセメントを注入する。

文 献

- 1) 日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会（編）：がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2020年版，金原出版，2020
- 2) 世界保健機関（竹田文和訳）：がんの痛みからの解放—WHO方式がん疼痛治療法—，金原出版，p17, 1996
- 3) World Health Organization. WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. World Health Organization, Geneva, 2018 (<https://www.who.int/ncds/management/palliative-care/cancer-pain-guidelines/en/>)
- 4) Basch E, et al : JAMA **318** : 198, 2017
- 5) Diel IJ, et al : Support Care Cancer **15** : 1243, 2007
- 6) Cleeland CS, et al : Cancer **119** : 832, 2013
- 7) Aparasu R, et al : J Pain Symptom Manage **18** : 280, 1999
- 8) Chow E, et al : J Clin Oncol **25** : 1423, 2007